



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA KOMITE PKRS
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**



LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Kerja Komite Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

Rumah Sakit Prima Husada

Tahun 2025

Disusun Oleh :

Penanggung Jawab Program PKRS

(Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes)

Disetujui Oleh :

Authorized Person

(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan Oleh :

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 962.12/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, khususnya di rumah sakit, serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna, perlu dilakukan promosi kesehatan di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit, maka perlu diatur dengan peraturan direktur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Promosi Kesehatan

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
 3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Keputusan Direktur Jendral No. HK-02-02-D-47104-2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika No. 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
 11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika No. 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN KERJA
PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
- (3) Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses memberdayakan Pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal.
- (4) Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit dengan nama jabatan Kepala, Direktur Utama, atau Direktur.
- (5) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
- (6) Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SDM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan.
- (7) Keluarga Pasien adalah setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (8) Pengunjung Rumah Sakit adalah setiap orang yang datang mengunjungi Rumah Sakit untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan yang lain.
- (9) Masyarakat Sekitar Rumah Sakit adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau berinteraksi di area sekitar Rumah Sakit.



Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan PKRS bertujuan untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam menyelenggarakan Promosi Kesehatan secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkelanjutan bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat sekitar Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan PKRS
- (2) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan.
- (3) Penyelenggaraan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan manajemen PKRS; dan
 - b. Pemenuhan standar PKRS.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh :
 - a. Kepala atau Direktur Rumah Sakit;
 - b. Tim PKRS RS Prima Husada;
 - c. Unit kerja fungsional yang dibentuk oleh professional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tim yang didasarkan pada kelas Rumah Sakit.
- (3) Professional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.
- (4) Pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur organisasi lainnya.



BAB II

MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 5

Manajemen PKRS meliputi ;

- a. Pengkajian;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Monitoring evaluasi

Pasal 6

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk melihat penyebab factor risiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan non perilaku.
- (2) Pengkajian bagi Pasien dan Keluarga Pasien dapat dilakukan berdasarkan formulir pengkajian pasien (*assessment patient*).
- (3) Pengkajian bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat sekitar Rumah Sakit dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang meliputi :
 - a. Data demografi;
 - b. Data penyakit;
 - c. Data kunjungan; dan
 - d. Data perilaku.
- (4) Pengkajian bagi SDM Rumah Sakit dilaksanakan dengan menggunakan instrument identifikasi perilaku

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penetapan tujuan dan sasaran;
 - b. Penentuan materi;
 - c. Penentuan metode berdasarkan tujuan dan sasaran;
 - d. Penentuan media;
 - e. Penyusunan rencana evaluasi; dan
 - f. Penyusunan jadwal pelaksanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan instalasi, unit, atau tim lain secara berkesinambungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dilakukan sesuai dengan standar PKRS.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid dan akurat, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan PKRS dan mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKRS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrument tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala dan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen PKRS tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.



BAB III

STANDAR PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

Standar PKRS meliputi :

- a. Rumah Sakit memiliki regulasi Promosi Kesehatan;
- b. Rumah Sakit melaksanakan asesmen Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit;
- c. Rumah Sakit melaksanakan intervensi Promosi Kesehatan; dan
- d. Rumah Sakit melaksanakan monitoring dan evaluasi Promosi Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit memiliki regulasi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk menjamin terselenggaranya manajemen PKRS yang optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (2) Regulasi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan Promosi Kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit;
 - b. Organisasi PKRS beserta tugas, fungsi, wewenang;
 - c. Tenaga pengelola PKRS yang kompeten dan sesuai dengan jumlah kapasitas tempat tidur Rumah Sakit;
 - d. Penyediaan anggaran serta sarana dan prasarana untuk terselenggaranya program PKRS; dan
 - e. Pelaksanaan Promosi Kesehatan berkelanjutan.

Pasal 13

Pelaksanaan asesmen Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :

- a. Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien;
- b. Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit; dan
- c. Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat sekitar Rumah Sakit.

Pasal 14

- (1) Intervensi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen Promosi Kesehatan.
- (2) Intervensi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasien dan keluarga pasien;
 - b. Intervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit; dan
 - c. Intervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat sekitar Rumah Sakit.

Pasal 15

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d meliputi :

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap intervensi Promosi Kesehatan; dan
- b. Peninjauan terhadap kebijakan, pedoman/panduan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan standar PKRS tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB IV ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Untuk terselenggaranya PKRS secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan PKRS.
- (2) Unit kerja fungsional (Tim PKRS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan tim PKRS.

Pasal 18

Tim PKRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat masyarakat yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sector lain terkait;
- e. Menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasioanal (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS;
- f. Membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan;
- g. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi;
- i. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara PKRS;
- j. Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan professional pemberi asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit; dan
- l. Mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.



BAB V
PENILAIAN & PEMBINAAN PKRS

Pasal 19

- (1) Penilaian penyelenggaraan PKRS dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Penilaian internal PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap satu bulan sekali oleh Tim PKRS sebagai bagian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKRS di unit, ruang dan instalasi.
- (3) Penilaian eksternal PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan Komunikasi dan Edukasi dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (No. HK.01.07/MENKE/1596/2024) Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan Tim PKRS dilakukan oleh Dewas Pakar PKRS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKRS di unit, ruang, instalasi dilakukan oleh tim PKRS.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Advokasi dan sosialisasi;
 - b. Bimbingan teknis; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.



**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 22

- (2) Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.M.Kep

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR : 962.12/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG : PEDOMAN KERJA PROMOSI
KESEHATAN RUMAH SAKIT

PEDOMAN KERJA PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan Institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, meliputi promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Dalam konteks transformasi kesehatan nasional, Rumah Sakit dituntut tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar terciptan perilaku hidup sehat. Pelayanan promotive dan preventif di Rumah Sakit dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan PKRS. Untuk itu Rumah Sakit berperan penting dalam melakukan Promosi Kesehatan baik untuk pasien, keluarga pasien, SDM Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, maupun masyarakat sekitar Rumah Sakit.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Promosi Kesehatan yang terstruktur, berkesinambungan, dan terukur.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit secara khusus mengatur prinsip, tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pelaksanaan PKRS di Rumah Sakit. Regulasi ini tetap menjadi acuan teknis yang relevan dalam penyelenggaraan PKRS hingga saat ini.

Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan pada 5 (lima) tingkat pencegahan yang meliputi Promosi Kesehatan pada kelompok masyarakat yang sehat sehingga mampu meningkatkan kesehatan, Promosi Kesehatan tingkat preventif pada kelompok berisiko tinggi (*high risk*) untuk mencegah agar tidak jatuh sakit (*specific protection*), Promosi Kesehatan tingkat kuratif agar pasien cepat sembuh atau tidak menjadi lebih parah (*early diagnosis and prompt treatment*), Promosi Kesehatan pada tingkat rehabilitatif untuk membatasi atau mengurangi kecacatan (*disability limitation*), dan Promosi Kesehatan pada pasien baru sembuh (*recovery*) dan pemulihan akibat penyakit (*rehabilitation*).

Dengan terselenggaranya Promosi Kesehatan di Rumah Sakit dapat mewujudkan Rumah Sakit yang berkualitas yang memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit baik nasional maupun internasional. Integrasi Promosi Kesehatan dalam asuhan pasien melalui peningkatan komunikasi dan edukasi yang efektif juga dapat mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga akreditasi Rumah Sakit, menunjukan bahawa sebagian besar kejadian sentinel disebabkan karena ketidakefektifan dalam berkomunikasi, baik antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA), maupun antara PPA dengan pasien. Selain itu, penyelenggaraan PKRS yang baik dan berkesinambungan dapat menciptakan perubahan perilaku dan lingkungan berdasarkan kebutuhan pasien.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang dalam memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan dan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna di Rumah Sakit, diperlukan adanya PKRS melalui pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Terciptanya Masyarakat Rumah Sakit yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku pasien Rumah Sakit serta pemeliharaan



lingkungan Rumah Sakit dan memanfaatkan dengan baik semua pelayanan yang disediakan Rumah Sakit.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Memberikan acuan kepada Rumah Sakit dalam penyelenggaraan PKRS.
- b. Mewujudkan Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melindungi pasien dalam mempercepat kesembuhannya, tidak mengalami sakit berulang karena penyakit yang sama, dan meningkatkan perilaku hidup sehat.
- c. Mewujudkan Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga pasien agar mampu mendampingi pasien dalam proses penyembuhan dan mencegah pasien tidak mengalami sakit berulang, menjaga, dan meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, serta menjadi agen perubahan dalam hal kesehatan.
- d. Mewujudkan Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pengunjung Rumah Sakit agar mampu mencegah penularan penyakit dan perilaku hidup sehat.
- e. Mewujudkan Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman untuk SDM Rumah Sakit.
- f. Mewujudkan Rumah Sakit yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

1.3 Sasaran

- a. Direktur Rumah Sakit.
- b. SDM Rumah Sakit.
- c. Pasien dan Keluarga Pasien.
- d. Pengunjung Rumah Sakit.
- e. Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- f. Pemangku kepentingan terkait.



BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

2.1 Paradigma Sehat

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan atau penyembuhan penyakit. Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan berperan penting mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya promotive dan preventive dalam mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi pasien, keluarga pasien, SDM Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat, serta menjaga agar tetap dalam keadaan sehat. Penyelenggaraan PKRS mengedepankan upaya-upaya promotive dan preventif, dengan tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitative, sehingga seluruh aspek pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan dapat menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar.

Penyelenggaraan PKRS sangat membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka merubah perilaku pasien, keluarga pasien, SDM Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penyakit berulang karena perilaku yang sama, mencegah dan mengurangi risiko terjadinya penyakit, serta menjaga agar tetap dalam keadaan sehat, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu penyelenggaraan PKRS perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, kelembagaan, tenaga, sumber dana, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga penyelenggaraan Promosi Kesehatan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit, *patient safety*, dan terpenuhinya hak-hak pasien, dan menciptakan Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat.

2.2 Kesetaraan

Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sasaran. Penyelenggaraan PKRS harus dapat menjangkau seluruh sasaran dengan tidak membedakan baik akses dan mutu pelayanan. Promosi kesehatan harus dapat memberi akses terhadap yang membutuhkan maupun masyarakat umum, sehingga tidak ada ketimpangan baik berdasarkan sasaran, status social, ekonomi, suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.

2.3 Kemandirian

Penyelenggaraan PKRS mendorong pasien, keluarga pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri sehingga tidak mengalami sakit berulang karena perilaku yang sama serta mampu mencegah dan mengelola risiko terjadinya penyakit.

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dalam rangka memandirikan individu, keluarga pasien, dan masyarakat agar mampu menghadapi masalah-masalah kesehatan potensial (yang mengancam) yaitu dengan cara mencegahnya dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang sudah terjadi dengan cara menanganinya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, mampu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya (*problem solving*), baik masalah-masalah kesehatan yang sudah diderita maupun yang potensial (mengancam), secara mandiri (dalam batas-batas tertentu). Dengan demikian dapat terwujudnya tujuan dari pembangunan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomi.

2.4 Keterpaduan dan Kesiambungan

Penyelenggaraan PKRS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan multi profesi/multi disiplin yang ada di unit/instalasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan unit terkait lainnya. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan dalam rangka perubahan perilaku sasaran, yang berulang sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus melibatkan multi profesi/disiplin, instalasi/unit fungsional, lintas program dan lintas sector, dan kelompok masyarakat yang peduli kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan Promosi Kesehatan Rumah Sakit tidak terbatas pada pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit, melainkan sampai pada saat pasien pulang dan berkumpul dengan komunitas di masyarakat. Untuk itu penyelenggaraan PKRS terpadu dan terintegrasi dengan upaya Promosi Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit dan Puskesmas dapat bersinergi secara berkelanjutan.



BAB III MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Penyelenggaraan PKRS dilakukan dalam rangka memberdayakan pasien, keluarga pasien, SDM Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk berubah dari tidak tahu menjadi tahu (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek practice), agar dapat mencegah terjadinya penyakit dan meningkatkan kesehatan. Agar penyelenggaraan PKRS berjalan dengan baik, diperlukan adanya manajemen PKRS secara menyeluruh, yang meliputi :

3.1 Pengkajian

Pengkajian dilaksanakan oleh pelaksana PKRS di masing-masing instalasi/unit pelayanan Rumah Sakit setiap tahun, dengan pendekatan sasaran untuk melihat penyebab dan factor risiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan non perilaku. Perilaku meliputi pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan tindakan (*practice*). Pengetahuan yang dikaji antara lain apa yang diketahui oleh sasaran tentang penyakit, cara menghindari dan mengendalikan penyakit, cara memelihara kesehatan, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Sikap yang dikaji adalah respon sasaran terhadap kesehatan. Tindakan yang dikaji adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sasaran dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. Non perilaku meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, kebijakan kesehatan, Pendidikan kesehatan, kondisi ekonomi, social, budaya, Pendidikan, kebijakan publik berwawasan kesehatan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Non perilaku yang dikaji adalah factor yang terkait langsung dengan penyebab masalah kesehatan.

3.1.1 Pengkajian Bagi Pasien dan Keluarga

Pengkajian bagi pasien dan keluarga pasien dapat dilakukan berdasarkan formulir pengkajian pasien, dengan menganalisis formulis pengkajian pasien (*assessment patient*), yang meliputi status merokok, riwayat konsumsi alcohol, aktivitas fisik, status gizi, status social ekonomi, dan factor risiko lainnya terkait diagnose penyakitnya, penggunaan obat yang aman, dan rasional, penggunaan peralatan medis yang aman, nutrisi, manajemen nyeri, teknis rehabilitasi.

Berdasarkan demografi diuraikan menurut usia, etnis, tingkat Pendidikan, serta Bahasa yang digunakan termasuk hambatan komunikasi (kemampuan membaca, hambatan emosional, keterbatasan fisik dan kognitif serta kesediaan menerima informasi) agar edukasi dapat efektif.

3.1.2 Pengkajian bagi SDM Rumah Sakit

Pengkajian bagi SDM Rumah Sakit dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap keadaan SDM Rumah Sakit dengan menggunakan instrument asesmen SDM Rumah Sakit yang meliputi :

1. Karakteristik SDM Rumah Sakit, terdiri atas umur, jenis kelamin, tempat bekerja;
2. Status gizi, terdiri atas Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, LLA;
3. Kondisi kesehatan, terdiri atas tekanan darah, frekuensi nadi, gula darah sewaktu, kolesterol total, dan asam urat;
4. Perilaku, terdiri atas status merokok, riwayat konsumsi alcohol, aktivitas fisik, makan sayur dan buah, riwayat vaksinasi, cek kesehatan berkala dan risiko terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja; dan
5. Riwayat penyakit yang pernah diderita dan keluarga.



3.1.3 Penkajian terhadap Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat

Pengkajian terhadap Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat sekitar Rumah Sakit dilaksanakan menggunakan data sekunder yang terdiri atas data demografi, data penyakit, data kunjungan dan data perilaku. Data demografi diuraikan menurut usia, etnis, agama, tingkat Pendidikan, serta bahasa yang digunakan. Data penyakit yaitu data penyakit yang ditangani di Rumah Sakit dalam 1 tahun dikelompokkan berdasarkan diagnose penyakit. Data kunjungan yaitu dengan cara merinci kunjungan di setiap instalasi/unit dalam bulan 1 tahun terakhir. Data perilaku didapat dari hasil survey Rumah Sakit, atau survey kesehatan (Riskesdas)/survey kesehatan dari Lembaga lainnya. Untuk mengetahui dampak terhadap keberadaan Rumah Sakit serta pola penyakit di wilayah setempat, pengkajian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data kondisi lingkungan sekitar Rumah Sakit dan kondisi wilayah setempat seperti daerah endemis rabies, malaria, DHF, ds. Data dapat menggunakan laporan tahunan dari dinas kesehatan pemerintah daerah setempat, seperti data kejadian penyakit menular dan tidak menular, prevalensi stunting, gizi buruk, TBC, cakupan imunisasi lengkap, angka kematian ibu dan anak, dsb. Serta data terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat yang dapat dijadikan mitra.

Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, diperoleh data dan informasi profil masing-masing sasaran untuk menentukan kebutuhan aktivitas Promosi Kesehatan dari masing-masing sasaran, dan dijadikan dasar dalam membuat perencanaan PKRS. Untuk melakukan pengkajian terhadap pasien dan keluarga pasien serta pengkajian terhadap SDM Rumah Sakit dapat melihat formulir pengkajian pada lembar berikutnya.



LAMPIRAN FORM
PENGAJIAN SDM RSPHS / KESEHATAN KARYAWAN

Tanggal Pengkajian :

IDENTITAS	
Nama	Umur :
Gender	Pendidikan :
Jabatan	Unit Kerja :

PENGAJIAN FAKTOR RISIKO	
1. Apakah Anda Merokok ? ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak Pernah	
Jika jawaban Ya :	
a. Sejak usia berapa anda merokok ?.....	
b. Berapa batang sehari anda merokok ?.....	
c. Apakah ketika bangun tidur anda punya keinginan langsung merokok ?.....	
d. Apakah dalam waktu 6 bulan kedepan anda punya keinginan berhenti merokok ?.....	
Jika jawaban Pernah :	
a. Sejak usia berapa anda merokok ?.....	
b. Berapa batang sehari anda merokok ?.....	
c. Kapan mulai berhenti merokok ?.....	
d. Apakah dalam waktu 1 bulan kebelakang anda punya keinginan merokok kembali ?.....	
2. Apakah anda mengonsumsi alkohol ? ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak Pernah	
Jika jawaban Ya :	
a. Sejak usia berapa anda mengonsumsi alkohol ?.....	
b. Berapa kali anda mengonsumsi alkohol dalam seminggu ?.....	
c. Apakah dalam waktu 6 bulan kedepan anda punya keinginan berhenti mengonsumsi alkohol ?.....	
Jika jawaban Pernah :	
a. Sejak usia berapa anda mengonsumsi alkohol ?.....	
b. Berapa kali anda dalam seminggu mengonsumsi alkohol ?.....	
c. Kapan mulai berhenti mengonsumsi alkohol ?.....	
d. Apakah dalam waktu 1 bulan ke belakang anda punya keinginan kembali mengonsumsi alkohol ?.....	
3. Konsumsi sayur dan buah (Coret yang tidak perlu)	
a. Apakah setiap hari anda mengonsumsi sayur dan buah ? (Ya/Tidak)	
b. Jika Ya, berapa porsi sayur dan buah perhari ?.....	
4. Aktivitas Fisik	
a. Berapa kali dalam seminggu anda berolahraga teratur ?.....	
b. Apakah anda melakukan aktivitas fisik minimal 30 mneit dalam sehari ?.....	
c. Aktivitas fisik apa yang anda lakukan ?.....	
5. Riwayat Vaksinasi Coret yang tidak perlu	
a. Hepatitis : Ya/Tidak	
b. BCG : Ya/Tidak	
c. Campak : Ya/Tidak	
d. HPV (Khusus Perempuan) : Ya/Tidak	
e. Covid : Ya/Tidak ; 1) 1 kali 2) 2 kali 3) 3 kali	
6. Cek Kesehatan berkala	
a. Apakah anda melakukan pemeriksaan kesehatan berkala ?.....	
b. Kapan terakhir kali anda melakukan check up kesehatan ?.....	
7. Risiko Kerja (Kecelakaan, Tertular Penyakit, dan sebagainya)	



No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Ket
a.	Apakah tersedia Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja ?			
b.	Apakah APD selalu digunakan di tempat kerja ?			
c.	Apakah APD sudah melindungi diri dari risiko di tempat kerja			
d.	Apakah sudah mendapat pelatihan terhadap risiko bekerja ?			
e.	Apakah semua materi dapat dimengerti dan dipahami ?			
f.	Apakah semua materi dapat dilaksanakan ?			
g.	Apakah KIE tentang media Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ada ditempat kerja ?			
h.	Pada pekerjaan dengan risiko tertular penyakit apakah sudah mendapat imunisasi tertentu ?			
RIWAYAT PENYAKIT				
No	Riwayat Penyakit	Ya	Tidak	Ket
1	Kencing Manis			
2	Tekanan Darah Tinggi			
3	Penyakit Jantung			
4	Stroke			
5	Tumor / Kanker			
6	Asma			
7	PPOK			
8	Kolesterol tidak normal			
9	Riwayat cedera (operasi)			
10	Osteoporosis			
11	Alergi			
12	Psikomatik/ depresi/ cemas/ psikotik			
13	Lain-lain, sebutkan :			
Apakah anda membutuhkan konseling, coaching, dan konsultasi ? Jika "IYA", apakah anda bersedia mengikuti konseling, coaching, dan konsultasi ?				

Demikian Pengkajian Kesehatan Karyawan ini di isi dengan sebenar-benarnya, sesuai kondisi karyawan saat ini, supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karyawan
(.....)

Pasuruan,
Petugas
(.....)

3.2 Perencanaan

Perencanaan PKRS dibuat oleh pengelola PKRS, setiap tahun disetiap instalasi/unit pelayanan dengan melibatkan multi profesi/disiplin, Profesional Pemberi Asuhan (PPA), dan unsur lain yang terkait dengan Promosi Kesehatan bagi sasaran di Rumah Sakit. Perencanaan



PKRS dibuat berdasarkan hasil kajian kebutuhan Promosi Kesehatan, dengan menetapkan target capaian, kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga, dana dan menentukan metode pelaksanaan perubahan perilaku, yang akan dijadikan sebagai bahan dalam monitoring dan evaluasi. Perencanaan PKRS dapat menggunakan instrument perencanaan yang dapat dikembangkan sendiri oleh masing-masing Rumah Sakit.

Langkah-langkah dalam perencanaan PKRS sebagai berikut :

- Penetapan tujuan perubahan perilaku sasaran, mencakup target peningkatan pengetahuan, peningkatan sikap, peningkatan perilaku, dan peningkatan status kesehatan.
- Penentuan materi Promosi Kesehatan yang dibuat secara praktis mudah dipahami oleh sasaran.
- Penentuan metode berdasarkan tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya Rumah Sakit (tenaga, waktu, biaya, dan sebagainya).
- Penentuan media yang akan digunakan untuk membantu penyampaian informasi dan edukasi dengan Bahasa mudah dimengerti, meliputi media cetak, media audiovisual, media elektronik, media luar ruang, dan sebagainya.
- Penyusunan rencana evaluasi, meliputi waktu dan tempat pelaksanaan evaluasi, kelompok sasaran yang akan dievaluasi, pelaksanaan kegiatan evaluasi, dan sebagainya.
- Penyusunan jadwal pelaksanaan, meliputi tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, biaya yang dibutuhkan dan sebagainya. Jadwal pelaksanaan biasanya disajikan dalam bentuk *table/gantt chart*.

Perencanaan PKRS Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Perencanaan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan bersama dengan instalasi/ unit terkait lainnya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Rumah Sakit.

3.3 Strategi PKRS

3.3.1 Pemberdayaan Masyarakat Rumah Sakit

Pemberdayaan masyarakat Rumah Sakit, yang merupakan upaya membantu atau memfasilitasi sasaran, sehingga memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya. Berbagai metode pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di Rumah Sakit pada sasaran, antara lain berbentuk pelayanan konseling terhadap :

a. Pasien dan Keluarga Pasien

Pasien yang dirawat inap maupun rawat jalan dapat dilakukan beberapa kegiatan pemberdayaan Pasien dan Keluarga seperti :

- Konseling ditempat tidur (disebut juga *bedside health promotion*). Diskusi kelompok (untuk penderita yang dapat meninggalkan tempat tidur) terhadap upaya peningkatan kesehatan terhadap penyakit yang diderita, *biblioterapi* (menyediakan atau membacakan bahan-bahan bacaan bagi Pasien).
- Konseling penggunaan obat, alat bantu, dan sebagainya.
- Konseling terhadap diagnose penyakit yang diderita Pasien (Pemberdayaan Keluarga Pasien) misalnya diskusi kelompok dengan mengumpulkan Keluarga Pasien dalam upaya meningkatkan hidup sehat.
- Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemberdayaan Pasien dan Keluarga Pasien dalam konseling/edukasi adalah :
 - Semua intervensi dicatat dalam rekam medis
 - Intervensi dilaksanakan oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA).
 - Intervensi Promosi Kesehatan berjalan efektif harus memperhatikan demografi pasien, social budaya, tingkat Pendidikan, ekonomi, etnis, agama, Bahasa yang digunakan serta keyakinan atau nilai-nilai pasien.
 - Hambatan komunikasi, emosional dan motivasi untuk berubah, keterbatasan fisik dan kognitif.
 - Kesediaan Pasien menerima informasi.
 - Pemberdayaan Pasien dan Keluarga Pasien dalam Promosi Kesehatan berkelanjutan dilaksanakan pada pasien setelah pulang dari Rumah Sakit atau rujuk balik sesuai dengan hasil *re-asesmen* kebutuhan Promosi Kesehatan. Bentuk kegiatan dapat berupa :
 - Kunjungan rumah untuk melakukan konseling/edukasi kepada Pasien dan Keluarga Pasien dalam rangka upaya mengendalikan factor risiko penyakit dan peningkatan kesehatan,
 - Pembinaan komunitas dimana pasien sebagai bagia dari kelompok masyarakat peduli kesehatan seperti kelompok peduli TBC, HIV/AIDS,



Diabetes, Klub Jantung Sehat, Senam Hamil dan sebagainya. Pembinaan teknis medis dilakukan oleh Profesional sesuai dengan keahlian.

b. SDM Rumah Sakit

Dalam rangka merubah perilaku berdasarkan hasil asesmen, dilakukan intervensi perubahan perilaku, sesuai dengan kebutuhan Promosi Kesehatan, seperti intervensi terhadap : masih banyak SDM Rumah Sakit yang merokok, maka kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan :

- 1) Konseling merokok/*coaching* berhenti merokok.
- 2) Membudayakan aktivitas fisik setiap SDM Rumah Sakit dengan melakukan senam secara rutin setiap hari tertentu,
- 3) MCU Karyawan : dilakukan pengukuran kebugaran, edukasi terhadap risiko pekerjaan dan lingkungan terutama sampah medis,
- 4) Upaya pengendalian IMT normal, disetiap unit/instalasi sebagai *Agent of Change* (AoC) sebagai motto dalam perubahan perilaku,
- 5) Memberikan hadiah (*reward*) atau harus “dipaksa” menggunakan peraturan dan sanksi (*punishment*),
- 6) Peningkatan keterampilan SDM Rumah Sakit dengan pelatihan, sosialisasi bimbingan Teknik dan sebagainya.

c. Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit

Pelaksanaan Promosi Kesehatan dilakukan dalam rangka perubahan perilaku yang berisiko dengan peningkatan pengetahuan meliputi :

- 1) Seminar kesehatan penyuluhan terhadap penyakit yang berisiko tinggi dan berbiaya mahal dan terbanyak yang terjadi di Rumah Sakit baik *during/luring*.
- 2) Bakti sosial, dengan pemeriksaan kesehatan sederhana
- 3) Menumbuhkan sikap dan kemauan individu dan masyarakat sehingga dapat berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan lingkungan sehat.
- 4) Media komunikasi, media cetak (leaflet, poster, dan baliho), media massa penyedia informasi (koran, TV, radio, bulletin, penayangan video pada TV di tempat-tempat yang strategi, dan sebagainya),
- 5) Penyuluhan massa, demonstrasi/kampanye kesehatan,
- 6) Pembinaan Komunitas berbasis RS, pembentukan kelompok peduli kesehatan, pengembangan daerah binaan Rumah Sakit, dan
- 7) Penggerakan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit dan lain sebagainya.



3.3.2 Advokasi

Advokasi dibutuhkan apabila dalam upaya memberdayakan sasaran PKRS membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain, seperti dalam rangka pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi perlu dibuat kebijakan oleh Direktur atau Kepala Rumah Sakit tentang pelaksanaan Promosi Kesehatan terhadap hasil pengkajian Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat sekitar Rumah Sakit.

a. Kebijakan

Dukungan kebijakan dalam advokasi diperlukan antara lain kelembagaan, organisasi, tenaga, sarana dan prasarana.

Contoh :

- 1) Kebijakan lingkungan Rumah Sakit tanpa asap rokok (KTR)
- 2) Kebijakan tentang sampah baik sampah medis dan sampah non medis,
- 3) Kebijakan terhadap hasil pengkajian yang ditemukan pada sasaran dan lain sebagainya, perlu melakukan advokasi kepada wakil-wakil rakyat dan pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya
- 4) Kebijakan mengharuskan seluruh SDM Rumah Sakit menerapkan PHBS, kebijakan pelaksanaan PKRS harus dilaksanakan pada setiap unit/intalasi yang terintegrasi dan didukung oleh tenaga professional, dana sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

b. Metode dalam Advokasi

Metode advokasi antara lain : lobby, seminar, sosialisasi, dan workshop.

c. Data : dukungan : data demografi dan informasi keadaan situasi Rumah Sakit.

d. Tahapan-tahapan yang dapat memandu advokasi di Rumah Sakit sebagai berikut :

- 1) Memahami/menyadari persoalan yang diajukan
- 2) Tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan
- 3) Mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan dalam berperan
- 4) Menyepakati satu pilihan kemungkinan dalam berperan
- 5) Menyampaikan langkah tindak lanjut

Jika kelima tahapan tersebut dapat dicapai selama waktu yang disediakan untuk advokasi, maka dapat dikatakan advokasi tersebut berhasil. Langkah tindak lanjut yang tercetus di ujung perbincangan (misalnya dengan membuat disposisi pada usulan/proposal yang diajukan) menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan dukungan.

e. Bahan Advokasi

Kata-kata kunci dalam penyiapan bahan advokasi adalah “Tepat, Lengkap, Akurat, dan Menarik”. Artinya bahan advokasi harus dibuat :

- 1) Sesuai dengan sasaran (latar belakang pendidikannya, jabatannya, budayanya, kesibukannya, dan lain-lain).
- 2) Sesuai dengan lama waktu yang disediakan untuk advokasi
- 3) Mencakup unsur-unsur pokok, yaitu Apa, Mengapa, Dimana, Bilamana, Siapa, Melakukan, dan Bagaimana melakukannya (5W + 1H).
- 4) Memuat masalah dan pilihan-pilihan kemungkinan untuk memecahkan masalah.
- 5) Memuat peran yang diharapkan dari sasaran advokasi.
- 6) Memuat data pendukung, bila mungkin juga bagan, gambar, dan lain-lain.



3.3.3 Kemitraan

Baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun advokasi, prinsip-prinsip kemitraan harus ditegakkan. Kemitraan dilaksanakan atas dasar bahwa pelaksanaan Promosi Kesehatan yang baik tidak dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit itu sendiri, melainkan banyak unsur dan sector terkait, sehingga tujuan Promosi Kesehatan dapat merubah perilaku dapat tercapai. Kemitraan dikembangkan berdasarkan kebutuhan Promosi Kesehatan. Pengelolaan PKRS harus bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, (multi profesi, multi disiplin, dan seluruh instalasi/unit pelayanan fungsional, serta dinas kesehatan pemerintah daerah/lintas sector terkait, Puskesmas/fasilitas kesehatan tingkat pertama/jejaring pelayanan kesehatan, dan sumber-sumber yang ada di masyarakat seperti misalnya kelompok profesi, kelompok peduli kesehatan, pemuka agama, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lain-lain.

A. Prinsip Kemitraan

Dalam melaksanakan kemitraan ada 3 (tiga) prinsip dasar kemitraan yang harus diperhatikan yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

1) Kesetaraan

Kesetaraan menghendaki tidak diciptakannya hubungan yang bersifat hirarkhis (atas-bawah). Semua harus diawali dengan kesediaan menerima bahwa masing-masing berada dalam kedudukan yang sederajat. Keadaan ini dapat dicapai bila semua pihak bersedia mengembangkan hubungan kekeluargaan, yaitu yang dilandasi kebersamaan atau kepentingan bersama.

2) Keterbukaan

Dalam setiap langkah menjalin kerjasama, diperlukan adanya kejujuran dari masing-masing pihak. Setiap usul/saran/komentar harus disertai dengan itikad yang jujur, sesuai fakta, tidak menutup-nutupi sesuatu.

3) Saling menguntungkan

Solusi yang diajukan hendaknya selalu mengandung keuntungan disemua pihak (*win-win solution*). Misalnya dalam hubungan antara petugas Rumah Sakit dengan Pasien, maka setiap solusi yang ditawarkan hendaknya juga berisi penjelasan tentang keuntungannya bagi Pasien. Demikian juga dalam hubungan antara Rumah Sakit dengan pihak donator.

B. Landasan Kemitraan

Terdapat tujuh landasan (dikenal dengan sebutan : tujuh saling) yang harus diperhatikan dan dipraktikkan dalam membangun kemitraan, yaitu :

- 1) Saling memahami kedudukan dan kemampuan masing-masing
- 2) Saling mengakui kapasitas dan kemampuan masing-masing
- 3) Saling berupaya untuk membangun hubungan
- 4) Saling berupaya untuk mendekati
- 5) Saling terbuka terhadap kritik/saran, serta mau membantu dan dibantu
- 6) Saling mendukung upaya masing-masing
- 7) Saling menghargai upaya masing-masing.

C. Metode dan Media dalam Kemitraan

Metode yang dimaksud adalah metode komunikasi, karena baik pemberdayaan, advokasi, maupun kemitraan pada prinsipnya adalah proses komunikasi. Oleh sebab itu perlu ditentukan metode yang tepat dalam proses tersebut. Pemilihan metode harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kemas informasi, keadaan penerima informasi (termasuk social budayanya), dan hal-hal lain seperti ruang dan waktu. Media atau sarana informasi juga perlu dipilih dengan cermat mengikuti metode yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus memperhatikan sasaran atau penerima informasi. Bila penerima informasi tidak bias membaca misalnya, maka komunikasi tidak akan efektif jika digunakan media yang penuh tulisan. Atau bila penerima informasi hanya memiliki waktu yang sangat singkat, maka tidak akan efektif jika dipasang poster yang berisi kalimat terlalu Panjang.

D. Sumber Daya

Sumber daya utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan PKRS adalah sumber daya manusia yang professional, mempunyai kompetensi Promosi Kesehatan dengan telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dipersyaratkan, sarana/peralatan termasuk media komunikasi, dan atau anggaran. Sumber daya manusia yang utama untuk PKRS meliputi :



- 1) Semua petugas Rumah Sakit yang melayani Pasien (PPA, tenaga kesehatan lainnya.).
- 2) Tenaga khusus Promosi Kesehatan (yaitu para pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat).

3.3.4 Bina Suasana

Pengertian Bina Suasana yaitu penciptaan situasi yang kondusif untuk memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat tercipta dan berkembang jika lingkungan mendukung baik lingkungan fisik, social budaya, ekonomi dan politik.

3.4 Pelaksanaan Intervensi PKRS

Pelaksanaan PKRS dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan, dengan berbagai metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang professional. Pelaksanaan PKRS menjadi tanggung jawab instalasi/unit/tim PKRS serta melibatkan multi disiplin/multi profesi terkait sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Pelaksanaan PKRS dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan Promosi Kesehatan yang telah ditetapkan melalui strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan, yang meliputi :

Pelaksanaan PKRS sesuai dengan strategi pelaksanaan PKRS dilaksanakan sejak pasien masuk RS :

1) Admisi atau Pendaftaran

Promosi Kesehatan pada ruang pendaftaran. Begitu pasien masuk ke Gedung Rumah Sakit, maka yang pertama kali harus dikunjunginya adalah ruang/tempat pendaftaran, dimana terdapat loket untuk mendaftar. Mereka akan tinggal beberapa saat di ruang pendaftaran itu sampai petugas selesai mendaftar. Setelah pendaftaran selesai barulah mereka satu demi satu diarahkan ke tempat yang sesuai dengan pertolongan yang diharapkan. Kontak awal dengan Rumah Sakit ini perlu disambut dengan Promosi Kesehatan. Sambutan itu berupa salam hangat yang dapat membuat mereka merasa tenang berada di Rumah Sakit. Di ruang ini pula, disediakan informasi tentang Rumah Sakit tersebut yang dapat meliputi manajemen Rumah Sakit, dokter atau perawat jaga, pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit, serta informasi tentang penyakit baik pencegahan maupun tentang cara mendapatkan penanganan penyakit tersebut. Media informasi yang digunakan di ruang ini sebaiknya berupa poster dalam bentuk *neon box* yang memuat foto dokter dan perawat yang ramah disertai kata-kata "Selamat Datang, Kami Siap Untuk Menolong Anda" atau yang sejenis. Media yang lain yang dapat disiapkan di ruang ini misalnya *leaflet*, *factsheet*, dan TV.

2) Instalasi Gawat Darurat :

Keterbatasan waktu pelayanan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pasien, edukasi tambahan dapat dilakukan dengan cara professional dalam bidangnya melatih tenaga kesehatan untuk menjadi educator, kemudian dengan jalan mengumpulkan pasien, keluarga pasien, pengantar pasien dalam suatu ruangan dan dilakukan edukasi, dan diskusi kelompok, terhadap diagnose dan cara mengendalikan faktor risiko. Penggunaan alat peraga seperti panthom, lembar balik, leaflet, poster dan penayangan video edukasi lainnya sangat membantu proses edukasi, untuk itu media yang tepat dan rinci sangat dibutuhkan. Yang perlu diperhatikan edukasi dilakukan berdasarkan kelompok diagnose penyakit, pelaksanaan edukasi harus memperhatikan demografi, status social, kemampuan baca tulis, dan kesediaan menerima informasi.

3) Instalasi Rawat Inap

Bagi pengunjung pasien rawat inap, situasi kondisi rawat inap dapat berpengaruh pada psikologis pengunjung akan kondisi kesehatannya. Pembagian selebaran leaflet, poster, video informasi dan sebagainya yang dapat memberikan informasi tentang penyakit, dan cara mencegah dan menghindari dan mengendalikan sesuai dengan penyakit pasien yang akan mereka jenguk dapat dilakukan. Selain itu, beberapa Rumah Sakit melaksanakan penyuluhan kelompok kepada para pembesuk ini, yaitu dengan mengumpulkn mereka yang menjenguk pasien yang sama penyakitnya dalam satu ruangan untuk mendapat penjelasan dan berdiskusi dengan dokter ahli, atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih yang menangani penderita. Misalnya, 30 menit sebelum jam besuk para penjenguk pasien penyakit dalam diminta untuk berkumpul dalam satu ruangan. Kemudian datang dokter ahli



penyakit dalam dan tenaga kesehatan yang terlatih yang mengajak para penjenjeng berdiskusi tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien yang akan dijenjengnya. Pada akhirnya diskusi, dokter ahli penyakit dalam atau tenaga kesehatan yang terlatih tadi berpesan agar hal-hal yang telah di diskusikan disampaikan juga kepada pasien yang akan dijenjeng.

4) Instalasi Rawat Jalan

Edukasi dilakukan kepada seluruh pasien, yaitu dimana setiap petugas Rumah Sakit yang melayani pasien meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien berkenaan dengan penyakitnya atau obat, atau perilaku yang harus dilakukannya. Selain itu juga disediakan satu ruang khusus bagi pasien rawat jalan yang memerlukan konsultasi atau ingin mendapatkan informasi. Ruang konsultasi ini disediakan di poliklinik dan dilayani oleh PPA sesuai dengan poliklinik yang bersangkutan. Tugas melayani dalam ruang konsultasi ini dapat digilir diantara PPA yang ada, yaitu mereka yang tidak bertugas di poliklinik, diberi tugas di ruang konsultasi. Konsultasi seyogyanya dilakukan secara individual. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan dilakukan konsultasi secara berkelompok (5-6 pasien sekaligus), jika keadaan memungkinkan. Jika demikian, maka ruang konsultasi ini sebaiknya cukup luas untuk menampung 6-7 orang. Ruang konsultasi sebaiknya dilengkapi dengan berbagai media komunikasi atau alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan. Media komunikasi yang efektif digunakan disini misalnya adalah lembar balik (*flash cards*), gambar-gambar atau model-model anatomi, dan tayangan menggunakan OHP atau laptop dan LCD. Seorang pasien yang hendak dioperasi katarak, mungkin menginginkan penjelasan tentang proses operasi katarak tersebut. Jika demikian, maka selain penjelasan lisan, tentu akan lebih memuaskan jika dapat disajikan gambar-gambar tentang proses operasi tersebut. Bahkan lebih bagus lagi jika dapat ditayangkan rekaman tentang proses operasi katarak melalui laptop dan LCD yang diproyeksikan ke layar.

5) Pengunjung /Pengantar Pasien

Bagi pengunjung/pengantar Pasien ke Rumah Sakit. Mereka ini tidak dalam keadaan sakit, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai media komunikasi yang tersedia di poliklinik. Oleh karena itu di setiap poliklinik, khususnya di ruang tunggu, perlu dipasang poster-poster, disediakan selebaran (*leaflet*), atau dipasang TV dan VCD/DVD player yang dirancang untuk secara terus menerus menayangkan informasi tentang penyakit sesuai dengan poliklinik yang bersangkutan. Dengan mendapatkan informasi yang benar mengenai penyakit yang diderita pasien yang diantaranya, si pengantar diharapkan dapat membantu Rumah Sakit memberikan juga penyuluhan kepada pasien. Bahkan jika pasien yang bersangkutan juga dapat ikut memperhatikan *leaflet*, poster atau tayangan yang disajikan, maka seolah-olah ia berada dalam suatu lingkungan yang mendorong untuk berperilaku sesuai yang dikehendaki agar penyakit atau masalah kesehatan yang dideritanya dapat segera diatasi.

6) Kasir atau Tempat Pembayaran

Promosi Kesehatan di tempat pembayaran. Sebelum pulang, pasien rawat inap yang sudah sembuh atau kerabatnya harus singgah dulu di tempat pembayaran. Di ruang perpisahan ini pasien/kerabatnya itu memang tidak berada terlalu lama. Promosi Kesehatan juga masih hadir, yaitu untuk menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat jalan, semoga semakin bertambah sehat, mengingatkan pesan dokter dan perawat. Perlu juga disampaikan bahwa kapan pun kelak pasien membutuhkan lagi pertolongan, jangan ragu-ragu untuk datang lagi ke Rumah Sakit. Datang diterima dengan salam hangat dan pulangpun diantar dengan salam hangat. Biarlah kenangan yang baik selalu tertanam dalam ingatan pasien/kerabatnya, sehingga mereka benar-benar menganggap Rumah Sakit sebagai penolong yang baik.

7) Laboratorium

PKRS di pelayanan laboratorium. Sasaran : Pasien, klien (orang sehat), dan para pengantarnya, kesadaran yang ingin diciptakan adalah pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium. Bagi pasien adalah untuk ketepatan diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Bagi keluarga pasien atau mereka yang sehat lainnya adalah untuk memantau kondisi kesehatan, untuk tetap sehat itu dikawasan ini sebaiknya dilakukan Promosi Kesehatan dengan media swalayan (*self service*) seperti poster-poster yang ditempel di dinding atau penyediaan *leaflet* yang dapat diambil gratis.

8) Radiologi



PKRS di pelayanan rontgen. Sebagaimana di pelayanan laboratorium, di pelayanan rontgen pun umumnya pasien, klien, dan para pengantarnya tidak tinggal terlalu lama. Disini kesadaran yang ingin diciptakan dalam diri mereka pun serupa dengan di pelayanan laboratorium, yaitu pentingnya melakukan rontgen. Bagi pasien adalah untuk ketepatan diagnosis yang dilakukan oleh dokter, bagi keluarga pasien atau mereka yang sehat lainnya adalah untuk memantau kondisi kesehatan, agar dapat diupayakan untuk tetap sehat. Dengan demikian, Promosi Kesehatan yang dilaksanakan disini juga dengan memanfaatkan media swalayan seperti poster dan leaflet.

- 9) PKRS di pelayanan obat/optik juga dijumpai baik pasien, klien, maupun pengantarnya. Kesadaran yang ingin diciptakan adalah terutama tentang manfaat obat generik dan keuntungan menggunakan obat generik. Kedisiplinannya dan kesabaran dalam menggunakan obat, sesuai dengan petunjuk dokter. Pentingnya memelihara Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dalam rangka memenuhi kebutuhan akan obat-obatan sederhana. Di pelayanan obat/optik boleh jadi pasien, klien, atau pengantarnya tinggal agak lama, karena menanti disiapkan obat. Dengan demikian, selain poster dan leaflet, di Kawasan ini juga dapat dioperasikan VD/DVD Player dan TV yang menayangkan pesan-pesan tersebut diatas.
- 10) PKRS di pelayanan pemulasaran jenazah tentu tidak akan dijumpai pasien, karena yang ada adalah pasien yang sudah meninggal dunia. Yang akan dijumpai di Kawasan ini adalah para keluarga pasien atau teman-teman pasien (jenazah) yang mengurus pengambilan jenazah dan transportasinya. Adapun kesadaran dan perilaku yang hendak ditanamkan kepada mereka adalah tentang pentingnya memantau dan menjaga kesehatan dengan mempraktikkan PHBS. Namun perlu diingat bahwa di Kawasan ini suasananya adalah berkabung, sehingga tidak mungkin dilakukan Promosi Kesehatan yang formal dan ketat. Dengan demikian, cara yang paling tepat adalah dengan memasang poster-poster dan atau pesan dalam poster dan leaflet juga dikaitkan dengan pesan-pesan keagamaan.

3.6 Monitoring dan Evaluasi

3.6.1 Monitoring

Monitoring dilaksanakan oleh tenaga pelaksana PKRS untuk memantau pelaksanaan PKRS agar sesuai dengan yang diharapkan dan apabila tidak sesuai dapat sedini mungkin menemukan dan memperbaiki hambatan dalam pelaksanaan. Monitoring dilaksanakan segera setelah melaksanakan kegiatan Promosi Kesehatan sampai berakhir pelaksanaan karena dengan dilakukannya monitoring akan dapat dilakukan perbaikan, perubahan orientasi, atau desain dalam system pelayanan PKRS, bila diperlukan untuk menyesuaikan strategi komunikasi dan pesan-pesannya, berdasarkan temuan dalam monitoring. Monitoring dilaksanakan oleh petugas yang melaksanakan Promosi Kesehatan itu sendiri.

A. Materi Monitoring

Kegiatan monitoring PKRS antara lain mencakup pengamatan tentang :

- a. Kebijakan sudah tersosialisasikan pada seluruh sasaran, pedoman/ panduan/ prosedur kerja (SPO) dimengerti dan sudah sesuai dengan sasaran;
- b. Pengkajian pasien apakah sudah dilaksanakan dan dicatat pada rekam medis;
- c. Materi komunikasi apakah sudah memuat secara detail sesuai dengan sasaran, mudah dipahami, dan kecukupan media apakah tersedia seperti poster. Lembar balik, leaflet, media luar ruang, media elektronik, dan sebagainya.
- d. Kegiatan edukasi seperti konseling, bibilo terapi, penyuluhan kelompok, penyuluhan massa, diskusi kelompok, kunjungan rumah dan lain sebagainya, frekuensi dan waktu pelaksanaannya apakah sudah mencukupi.
- e. Kecukupan tenaga dan pelatihan apakah sudah sesuai dengan jumlah sasaran selama intervensi diamati reaksi sasaran seperti efektivitas pelaksanaan, target sasaran dengan yang diharapkan. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka dilakukan perbaikan-perbaikan.

B. Bentuk Kegiatan Monitoring dapat berupa :

- a. *Open Medical Record Review* yaitu metode telusur asuhan pasien yang dilakukan pada saat pasien masih dirawat. Pada metode ini memungkinkan untuk langsung diklarifikasi kepada pasien dibandingkan dengan yang dicatat di rekam medik.
- b. *Close Medical Record Review* yaitu metode telusur asuhan pasien melalui rekam medik pada saat pasien sudah pulang perawatan.
- c. Melakukan wawancara pada saat pasien pulang/ atau selesai mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.



- d. *Focus Group Discussions* antara pelaksana-pelaksana PPA dimana PKRS dilaksanakan pada instalasi/unit pelayanan di Rumah Sakit.
- e. Melakukan supervisi dan pembinaan ke instalasi/ unit-unit pelaksana PKRS oleh pengelola PKRS.
- f. Menyelenggarakan pertemuan pengelola PKRS secara rutin (bulanan, triwulan, enam bulan, dan tahunan) untuk membahas permasalahan dan kendala terkait pelaksanaan PKRS.

3.6.2 Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan PKRS. Pelaksanaan evaluasi PKRS dilaksanakan dengan mengukur proses kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, mencakup pencatatan kegiatan PKRS, target, sasaran dan hasil pencapaian.

a. Pengukuran terhadap *effectiveness* yaitu :

- 1) Berapa frekuensi intervensi PKRS tercapai dibandingkan target yang sudah ditetapkan,
- 2) Ketepatan sasaran dan materi pemberian intervensi PKRS,
- 3) Efficiency yaitu pengukuran biaya dari sumber daya yang dipakai untuk mencapai tujuan dan target PKRS.
- 4) Membandingkan antara *input* dan *output*, pengaruh yang terlihat setelah pelaksanaan pemberian intervensi PKRS seperti complain, LOS, klaim BPJS, angka sentinel, readmisi, infeksi nasokomial, kepuasan pasien, hari absen karyawan akibat sakit, banyaknya kelompok/komunitas masyarakat yang berpartisipasi, dan sebagainya.

b. Metode Evaluasi

Penentuan metode evaluasi yang digunakan tergantung dari beberapa factor antara lain :

- 1) Tujuan pelaksanaan PKRS, misalnya hanya bertujuan meningkatkan kesadaran, perubahan perilaku, atau sampai penurunan risiko.
- 2) Dasar perbandingan, bias berdasarkan perubahan dalam jangka waktu tertentu (pada kelompok pasien yang diintervensi, misalnya hasil setelah diintervensi dibandingkan dengan awal sebelum diintervensi), atau perubahan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- 3) Sumber daya yang ada, misalnya dengan pencatatan sederhana, uji statistik, atau sampai pada analisis epidemiologis.

c. Bentuk kegiatan pelaksanaan evaluasi PKRS berupa :

- 1) Pertemuan forum komunikasi dalam bentuk rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala instalasi/unit terkait dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PKRS.
- 2) Menjalin kerja sama jaringan regional, nasional, dan internasional maupun kelompok Rumah Sakit yang telah melaksanakan PKRS dengan baik sesuai standard.
- 3) Menginformasikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi PKRS melalui forum komunikasi atau berbagai jenis media.
- 4) Melakukan studi banding terhadap Rumah Sakit yang telah melaksanakan PKRS dengan lebih baik.
- 5) Kajian Mutu oleh unit fungsional internal mutu Rumah Sakit atau menggunakan pihak lain untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKRS.



Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit sekurang-kurangnya setiap 3 bulan. Hal-hal yang perlu dilaporkan yaitu terkait kegiatan PKRS dan capaian pelaksanaan standar PKRS. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan PKRS dapat menggunakan contoh instrument monitoring dan evaluasi PKRS sebagai berikut :

FORM LAPORAN PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN

Rumah Sakit

Bulanan/Semester/Tahun

No	Indikator	Jumlah	Target	Capaian (%)	Keterangan
1	Pasien yang dilakukan pengkajian awal kebutuhan promosi kesehatan dan dicatat dalam rekam medik				
2	Pasien dan keluarga pasien yang dilakukan edukasi sesuai kebutuhan dicatat dalam rekam medik				
3	Pasien dan keluarga pasien yang dilakukan edukasi diberikan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)				
4	Pasien yang pada saat persiapan pulang/rujuk balik dilakukan <i>re-asesmen</i> promosi kesehatan				
5	Pasien sesuai dengan kebutuhan dengan penyakit tertentu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terkait Promosi Kesehatan				
6	Media yang dibuat sesuai dengan pengkajian kebutuhan Promosi Kesehatan				
7	Penyakit yang ditemukan di Rumah Sakit, dibuat media KIE kesehatan secara detail				
8	Sumber daya manusia Rumah Sakit berperilaku hidup bersih dan sehat ditempat kerja				
9	Sumber daya manusia Rumah Sakit dilakukan asesmen Promosi Kesehatan				
10	Sumber daya manusia Rumah Sakit yang dilakukan asesmen mengikuti program intervensi Promosi Kesehatan				
11	Sumber daya manusia Rumah Sakit yang telah dilakukan <i>medical check up</i>				



12	Sumber daya manusia Rumah Sakit dalam kondisi bugar				
13	Pasien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit puas terhadap pelaksanaan Promosi Kesehatan Rumah Sakit				
14	Hasil asesmen pasien, keluarga pasien, pengunjung Rumah Sakit, sumber daya manusia Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit dibuatkan kebijakan pelaksanaan Promosi Kesehatan				
	1.....				
	2.....				
	3.....dst				
15	Angka kejadian yang tidak diharapkan yang diakibatkan oleh komunikasi dan edukasi yang tidak efektif				
16	Sumber-sumber yang ada di komunitas yang telah bekerjasama dengan Rumah Sakit dalam rangka Promosi Kesehatan berkelanjutan dilakukan pembinaan				
17	Angka <i>readmisi</i> yang tidak direncanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari				
18	Program pembinaan dan pencegahan penyakit bagi masyarakat sekitar Rumah Sakit				
	1.....				
	2.....				
	3.....dst				



BAB IV STANDAR PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Standar PKRS merupakan ukuran yang dipakai sebagai patokan pelaksanaan PKRS. Standar PKRS dikembangkan berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sehingga dapat mewujudkan Rumah Sakit yang mempromosikan kesehatan secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan. Standar PKRS disusun dengan mengakomodasi kebijakan-kebijakan nasional bidang kesehatan. Standar PKRS meliputi:

4.1 STANDAR 1 : (Rumah Sakit Memiliki Regulasi Promosi Kesehatan)

Rumah Sakit memiliki regulasi tertulis tentang pelaksanaan Promosi Kesehatan, yang terkoordinasi dan berkelanjutan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit. Regulasi Promosi Kesehatan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya manajemen PKRS yang optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

4.1.1 Regulasi mengenai pelaksanaan Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit, meliputi :

- 1) Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit tentang pelaksanaan PKRS yang mencakup Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- 2) Rencana strategi yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit yang memuat Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

4.1.2 Regulasi mengenai organisasi PKRS adalah, meliputi :

- 1) Organisasi ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- 2) Jumlah SDM *Full Time* dalam organisasi PKRS didasarkan pada kelas Rumah Sakit.
- 3) Kelas Rumah Sakit Prima Husada adalah kelas C (4 orang pengelola)
- 4) Bentuk organisasi PKRS Rumah Sakit Prima Husada adalah Tim
- 5) Terdapat SK Tim PKRS yang ditetapkan oleh Direktur
- 6) Kualifikasi dalam Organisasi PKRS minimal terdiri atas :
 - a. Ketu Tim fungsional PKRS, yang dijabat oleh tenaga kesehatan, minimal Pendidikan S1 Kesehatan, dan telah mendapatkan pelatihan pengelolaan PKRS.
 - b. Pengelolaan PKRS, adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan fungsional Promosi Kesehatan, dan tenaga non kesehatan yang mempunyai kompetensi Promosi Kesehatan dan telah mendapatkan pelatihan teknis pengelola PKRS.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Tim PKRS yaitu :

- 1) Melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan di Rumah Sakit dan asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan, meliputi Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.
- 3) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- 4) Menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan pemerintah daerah, Puskesmas dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait.
- 5) Menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS, dengan melibatkan multi disiplin/profesi.
- 6) Membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan dengan melibatkan multi profesi/disiplin yang berkompeten.
- 7) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS.
- 8) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap triwulan. Pelaporan disampaikan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit, kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Menteri Kesehatan.
- 9) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana PKRS.



- 10) Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan PKRS.
- 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan Profesi Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
- 12) Mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

4.1.4 Wewenang Instalasi/Unit Promosi Kesehatan, antara lain :

- 1) Menyenggarakan Promosi Kesehatan secara bermutu dan berkelanjutan.
- 2) Menyenggarakan Promosi Kesehatan yang berorientasi pada Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- 3) Menyenggarakan Promosi Kesehatan yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan Pasien, Keluarga Pasien, Pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- 4) Menyenggarakan Promosi Kesehatan dengan prinsip koordinatif, integrative, kerja sama inter dan antar profesi.
- 5) Melaksanakan pencatatan intervensi Promosi Kesehatan bagi Pasien dalam rekam medis.
- 6) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Promosi Kesehatan.
- 7) Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga PKRS.
- 8) Melaksanakan pembinaan teknis Promosi Kesehatan pada sumber-sumber di komunitas dalam rangka Promosi Kesehatan berkelanjutan.

4.1.5 Tenaga Pengelola PKRS

Tenaga pengelola PKRS yang kompeten dan sesuai dengan jumlah kapasitas tempat tidur Rumah Sakit. Tenaga pengelola PKRS yang ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit. Jumlah minimal tenaga pengelola PKRS berdasarkan kapasitas Tempat Tidur (TT) Rumah Sakit yaitu :

No	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tenaga
1	Jumlah TT <100	: minimal 2 orang
2	Jumlah TT 101-300	: minimal 4 orang
3	Jumlah TT 301-700	: minimal 6 orang
4	Jumlah TT >700	: minimal 10 orang



4.1.6 Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pengelola PKRS adalah sebagai berikut :

- 1) Kompetensi teknis pengelola PKRS meliputi kompetensi bidang Promosi Kesehatan, yaitu kemampuan merencanakan PKRS, Advokasi, Komunikasi dan Edukasi pada Pasien dan Keluarga Pasien, Promosi Kesehatan berkelanjutan, penggerakan masyarakat, pembuatan dan pengembangan media Promosi Kesehatan.
- 2) Kompetensi dibuktikan dengan ijazah/sertifikat pelatihan.

4.1.7 Pendidikan dan Pelatihan

A. Jenis pelatihan yang dipersyaratkan bagi pengelolaan PKRS meliputi :

- 1) Pelatihan pengelolaan PKRS.
- 2) Pelatihan komunikasi dan edukasi efektif bagi Professional Pemberi Asuhan.
- 3) Pelatihan manajemen Promosi Kesehatan dalam proses asuhan untuk Profesional Pemberi Asuhan.
- 4) Pelatihan teknis media Promosi Kesehatan.
- 5) Pelatihan metode dan teknis PKRS.

B. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh institusi yang berwenang seperti :

Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah/ Organisasi Profesi/ Jejaring HPH/ PPKMI dengan menggunakan kurikulum dan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

C. Program peningkatan kompetensi dan kapasitas Promosi Kesehatan meliputi :

- 1) Pelatihan Komunikasi dan Edukasi Efektif bagi seluruh Profesional Pemberi Asuhan.
- 2) Pelatihan Manajemen PKRS.
- 3) Pelatihan teknis pembuatan dan pengembangan media PKRS.
- 4) Keikutsertaan dalam konferensi/ seminar/ symposium nasional/ internasional tentang PKRS.

4.1.8 Anggaran Program PKRS

Penyediaan anggaran serta sarana dan prasarana untuk terselenggaranya program PKRS, meliputi :

- a. Tersedia anggaran untuk kegiatan PKRS serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung PKRS yang tertuang dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) Rumah Sakit. Anggaran kegiatan PKRS meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, peningkatan kapasitas pengelola PKRS, pengadaan media PKRS, dan pengadaan peralatan penunjang PKRS.
- b. Tersedia sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PKRS paling sedikit terdiri atas :

No	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan
1	Ruang edukasi/penyuluhan	1 ruangan
2	Ruang pengelola	1 ruangan
3	Laptop	1 set
4	LCD Proyektor	1 set
5	Layar Proyektor	1 set
6	<i>Portable Sound System</i>	1 set
7	<i>Food Model</i>	1 set
8	Panthom anatomi	1 set
9	Panthom gigi	1 set
10	Biblioterapi	1 set
11	Papan informasi	1 set
12	Panthom mata	1 set
13	Panthom panggung	1 set
14	Alat permainan edukasi	1 set



15	Megaphone	1 set
16	VCD/DVD Player	

4.1.9 Pelaksanaan Promosi Kesehatan Berkelanjutan, meliputi :

- Pedoman dan prosedur kerja PKRS bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- Panduan Praktik Klinik (PPK) yang didalamnya tercantum aktivitas Promosi Kesehatan terintegrasi bagi Pasien.
- Program kerja PKRS yang melibatkan unit kerja lainnya, mencakup aktivitas Promosi Kesehatan.
- Pedoman implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Rumah Sakit atau Komunitas berbasis Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.
- Kebijakan tentang *green hospital* mencakup bangunan Rumah Sakit, pengolahan sampah, nutrisi, energi, dan perilaku.

4.2 STANDAR 2 : Rumah Sakit Melaksanakan Pengkajian Promosi Kesehatan

Adanya asesmen Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit diperlukan untuk mengetahui profil sasaran secara utuh sebagai dasar menentukan kebutuhan aktivitas Promosi Kesehatan.

- Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien meliputi :
 - Adanya hasil identifikasi kebutuhan Promosi Kesehatan yang dilakukan oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada saat asesmen awal dan tercatat dalam rekam medik pasien. Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan yang dilakukan, meliputi :
 - Status merokok
 - Riwayat konsumsi alkohol
 - Aktivitas fisik
 - Status nutrisi
 - Status sosial ekonomi
 - Factor risiko lainnya
 - Adanya hasil asesmen pendukung yang dilakukan oleh PPA untuk mendukung intervensi pemberi edukasi efektif bagi Pasien dan tertuang dalam rekam medik pasien. Asesmen pendukung yang dimaksud meliputi :
 - Keyakinan dan nilai-nilai Pasien dan Keluarga Pasien tentang kondisi kesehatan.
 - Kemampuan literasi (minimal kemampuan membaca)
 - Tingkat Pendidikan.
 - Penggunaan Bahasa.
 - Hambatan emosional dan motivasi untuk berubah.
 - Keterbatasan fisik dan kognitif.
 - Kesediaan pasien menerima informasi.
 - Adanya hasil asesmen yang dicatat dalam rekam medik pasien sebagai dasar dalam perencanaan program Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien.
 - Adanya hasil *re-asesmen* kebutuhan Promosi Kesehatan berkelanjutan pada saat pasien akan pulang. *Re-asesmen* dilakukan oleh PPA penanggungjawab pasien. Hasil *re-asesmen* lanjutan dapat dijadikan bahan untuk melakukan rujukan bagi pasien ke sumber-sumber yang ada di komunitas.
- Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit, meliputi :
 - Adanya hasil asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit, meliputi status merokok, riwayat konsumsi alkohol, aktivitas fisik, status gizi, social ekonomi, dan factor risiko lainnya.
 - Adanya pelaporan hasil asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit sebagai bahan penyusunan Program Promosi Kesehatan.
- Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit, meliputi :



- a. Adanya pelaporan hasil asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit sebagai bahan penyusunan program Promosi Kesehatan.
- b. Adanya data sumber-sumber di komunitas (misalnya Pesadia, komunitas jantung sehat, komunitas Pasien Kanker, Komunitas ODHA, dan lain-lain), atau fasilitas kesehatan lainnya yang dapat dijadikan mitra dalam pelaksanaan Promosi Kesehatan berkelanjutan.

4.3 STANDAR 3 : Rumah Sakit Melaksanakan Intervensi

Promosi Kesehatan Intervensi Promosi Kesehatan merupakan upaya sistematis dengan menerapkan metode dan strategi Promosi Kesehatan berdasarkan hasil asesmen Promosi Kesehatan, bertujuan untuk merubah perilaku Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit, agar mampu dapat mengidentifikasi faktor risiko penyakitnya, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi faktor risiko penyakit, mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatannya, serta menghindari terjadinya kesakitan berulang karena perilaku yang sama.

1. Intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasien dan keluarga (PCC) meliputi :
 - a. Adanya kegiatan pemberian informasi dan edukasi tentang faktor risiko penyakit sesuai kebutuhan pasien, meliputi status merokok, riwayat konsumsi alkohol, aktivitas fisik, status gizi, faktor social ekonomi, dan faktor risiko lainnya. Hasil pemberian informasi dan edukasi oleh Profesional Pemberi Asuhan kepada pasien dan keluarga dicatat dalam formulir rekam medik.
 - b. Adanya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang faktor risiko penyakit sesuai kebutuhan, meliputi status merokok, riwayat konsumsi alkohol, aktivitas fisik, status gizi, faktor sosial ekonomi, dan faktor risiko lainnya.
 - c. Adanya kegiatan pemberian informasi dan edukasi tentang diagnosis penyakit, penggunaan obat-obatan yang didapat pasien secara efektif dan aman, termasuk potensi efek samping obat, penggunaan peralatan medis secara efektif dan aman, potensi interaksi antara obat yang diresepkan dan obat lainnya termasuk obat yang tidak diresepkan serta makanan, diet dan nutrisi, manajemen nyeri, Teknik rehabilitasi, cara cuci tangan yang benar, dan sebagainya sesuai dengan hasil asesmen. Hasil pemberian informasi dan edukasi oleh PPA kepada pasien dan keluarga pasien dicatat dalam formulir rekam medik.
 - d. Adanya media KIE tentang diagnosis penyakit, penggunaan obat-obatan yang didapat pasien secara efektif dan aman, termasuk potensi efek samping obat, penggunaan peralatan medis secara efektif dan aman, potensi interaksi antara obat yang diresepkan dan obat lainnya termasuk obat yang tidak diresepkan serta makanan, diet dan nutrisi, manajemen nyeri, Teknik rehabilitasi, cara cuci tangan yang benar, dan sebagainya.
 - e. Adanya kunjungan rumah dalam rangka Promosi Kesehatan berkelanjutan terhadap kasus-kasus yang perlu ditindaklanjuti.
 - f. Adanya surat/formulir rujuk balik ke sumber-sumber di komunitas bagi pasien pulang untuk upaya Promosi Kesehatan berkelanjutan yang tercatat dalam rekam medik
 - g. Adanya daftar pasien yang dirujuk ke sumber-sumber di komunitas.
 - h. Adanya penyampaian informasi populasi pasien, penyakit, dan factor risiko yang ditemukan di Rumah Sakit untuk ditindaklanjuti di komunitas.
 - i. Adanya program pembinaan dan/atau intervensi bagi sumber-sumber di komunitas.
 - j. Adanya program kerjasama Rumah Sakit dengan sumber yang ada di komunitas tersebut untuk mendukung kebutuhan pasien dalam Promosi Kesehatan berkelanjutan.
 - k. Adanya kegiatan pembinaan Promosi Kesehatan kepada sumber-sumber, atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di komunitas tersebut agar sejalan dengan program kerja PKRS.
 - l. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan/atau intervensi di komunitas.
 - m. Adanya pencatatan intervensi Promosi Kesehatan bagi pasien dan keluarga pasien yang dicatat dalam rekam medik.
 - n. Adanya program pencegahan penularan penyakit bagi pasien, termasuk pencegahan infeksi nosokomial.
2. Intervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit, meliputi :



- a. Adanya program Promosi Kesehatan sebagai tindak lanjut dari asesmen kebutuhan SDM Rumah Sakit.
 - b. Terlaksananya program Promosi Kesehatan untuk SDM Rumah Sakit.
 - c. Adanya program pencegahan penularan penyakit bagi SDM Rumah Sakit, termasuk pencegahan infeksi nosokomial.
3. Intervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit, meliputi :
- a. Adanya akses informasi bagi Pasien, Keluarga pasien, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit. Informasi yang diberikan mencakup jenis pelayanan yang tersedia, akses dan jadwal pelayanan, serta proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Akses informasi dapat berupa :
 - 1) Website Rumah Sakit yang mencantumkan informasi tentang jenis pelayanan yang tersedia, akses dan jadwal pelayanan, serta proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - 2) Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kesehatan berupa media cetak (leaflet, flyer, poster, lembar balik, dan sebagainya), media luar ruangan (billboard, spanduk, dan sebagainya), dan media audiovisual.
 - b. Adanya kegiatan pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan umum, minimal yang berkaitan dengan perilaku cuci tangan pakai sabun, etika batuk, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, bahaya merokok, cek kesehatan secara rutin, dan ASI eksklusif.
 - c. Adanya media KIE tentang kesehatan umum, minimal yang berkaitan dengan perilaku cuci tangan pakai sabun, etika batuk, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, bahaya merokok, cek kesehatan secara rutin, dan ASI eksklusif.
 - d. Adanya kegiatan pemberian informasi dan edukasi tentang penyakit risiko tinggi, berbiaya tinggi, dan kasus terbanyak yang ada di Rumah Sakit, seperti Hipertensi, penyakit jantung, Stroke, penyakit ginjal, Diabetes, Kanker, Hepatitis, Thalasemia, Hemofilia, dan sebagainya.
 - e. Adanya media KIE tentang seluruh penyakit yang ditemukan di Rumah Sakit, media KIE dapat berupa poster, leaflet, flyer, standing banner, spanduk, lembar balik, video informasi, dan sebagainya.
 - f. Adanya program pencegahan penularan penyakit kepada masyarakat sekitar Rumah Sakit yang terdampak masalah kesehatan.
 - g. Adanya edukasi tentang Rumah Sakit ramah lingkungan.

4.4 STANDAR 4 : MONITORING DAN EVALUASI

Rumah Sakit melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Promosi Kesehatan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kegiatan PKRS, berjalan dengan baik, dan berkesinambungan, sesuai dengan standar.

Elemen :

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap intervensi Promosi Kesehatan, meliputi :
 - a. Monitoring kegiatan Promosi Kesehatan setiap bulan.
 - b. Adanya kegiatan evaluasi kegiatan Promosi Kesehatan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
 - c. Adanya instrument monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi Kesehatan.
 - d. Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi, meliputi hasil pencapaian standar PKRS. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada kepala atau Direktur Rumah Sakit.
 - e. Adanya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh instalasi/unit PKRS Bersama dengan instalasi/unit terkait.
 - f. Adanya data Promosi Kesehatan yang dikumpulkan secara rutin meliputi aktivitas Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung dan Masyarakat sekitar Rumah Sakit serta dapat dipantau setiap saat melalui system informasi.
 - g. Adanya pertemuan rutin antara Instalasi/Unit PKRS dengan sumber-sumber yang ada di komunitas untuk mengevaluasi program Promosi Kesehatan berkelanjutan.
 - h. Adanya penyampaian informasi tentang data populasi pasien, penyakit, dan factor risiko yang ditemukan di RS untuk ditindaklanjuti di komunitas.
 - i. Adanya survey kepuasan terhadap pelayanan/program Promosi Kesehatan minimal 6 bulan sekali.



- j. Adanya diseminasi dan tindak lanjut hasil survey kepuasan terhadap pelayanan/program Promosi Kesehatan minimal 6 bulan sekali.
2. Peninjauan terhadap kebijakan, pedoman/panduan dan standar prosedur operasional, meliputi :
 - a. Adanya hasil peninjauan kebijakan, pedoman, panduan, dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait PKRS dengan meliputi multi profesi/multi disiplin di Instalasi/Unit pelayanan terkait yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau bila diperlukan.
 - b. Adanya penelitian tentang PKRS minimal 1 kali dalam 1 tahun.
 - c. Adanya diseminasi dan tindak lanjut hasil penelitian tentang PKRS sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu Rumah Sakit.

BAB V PENUTUP

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan promotif dan preventif di Rumah Sakit dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan PKRS. Untuk itu Rumah Sakit berperan penting dalam melakukan Promosi Kesehatan baik untuk Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, maupun Masyarakat Sekitar Rumah Sakit. Selain itu PKRS juga diperlukan dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Dengan ditetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit ini maka diharapkan PKRS dapat terselenggara secara optimal, efektif dan efisien, terpadu dan berkesinambungan sehingga terbentuk perilaku hidup sehat pada Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit. Selain itu, penyelenggaraan PKRS juga harus mendapatkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Instalasi/Unit PKRS, namun juga membutuhkan keterlibatan seluruh Instalasi/Unit yang berada dalam Rumah Sakit dan dalam penyelenggaraannya perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instalasi kesehatan, jejaring, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, PKRS diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.KepS



FORM REKAPAN PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA/KIE

NAMA PETUGAS :
TANGGAL :

RUANG :
JUMLAH PASIEN :

NO	URAIAN	JUMLAH RM	JUMLAH RM TERISI	JML RM TERISI/TOTAL PASIE N X 100%
1	Form pengkajian kebutuhan angka 1-6 : 1. bahasa s/d 6. kebersediaan			
	Form Pengkajian yang terisi :			
	1) Penyakit : Dx, Gx, Tx, Prognosa, Comp likasi, Rx As			
	2) Gizi			
	3) R. Jatuh			
	4) Obat / riwayat obat minum sebelum MRS/alergi			
	5) Pengelolaan Nyeri			
	6) PHBS : a. Cuci tangan b. Prot kes c. Etika Batuk d. Cega Rokok /KTR/ bebas Utilias rokok			
	7) Fisio tx sesuai kondisi			
	8) Pemakaian alat medis/sesuaikan			
	9) Tiap kali melakukan tindakan			
	10) Lain-lain			
2	11) TTD + nama terang, Tgl, Jam			
	Pemberian informasi di admisi / pendaftaran			
	1) Tata tertib			
	2) Hak & Kewajiban pasien dan keluarga			
	3) Kesediaan			
	4) Fasilitas Kamar			
	5) Penandaan (Risiko Jatuh, populasi khusus, Risti dll)			
3	6) Gelang identitas – identifikasi			
	7) Pemilihan Kamar			
	IRNA			
	1) Nama DPJP + Waktu visite dokter			
	2) Perawat /bidan			
	3) Profesi Pemberi Asuhan lain			
	4) Orientasi Ruangan			
	5) Cara menggunakan toilet, air, listrik, sarpras			
	6) Cara buang sampah			
	7) Cara memanggil perawat / Nurse call			



	8) Cara menaruh tempat makanan			
	9) Cara meminta bimbingan doa			
	10) Persiapan pasien pulang/ Dischard Planning			
	11) Biaya			
	12) Lain-lain			
	13) TTD + nama terang, tanggal, jam			
4	Form edukasi kolaborasi siapa saja yang visite ?			
	1) Dokter/DPJP			
	2) Perawat /bidan			
	3) Ahli gizi			
	4) Farmasi			
	5) Rehab medis			
	6) TTD + nama terang, tanggal, jam			
	Verifikasi yang dilakukan petugas/ Katim/Karu			



REKAP PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA

NAMA PETUGAS :

TANGGAL :

RUANG :

JUMLAH PASIEN :

NO	URAIAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Form penilaian kebutuhan angka 1-6 : 1. Bahasa s/d 6. Kebersediaan															
	Form pengkajian yang terisi :															
	1) Penyakit Dx, Gx, Tx, Prognosa, Compplikasi, Rx Asuh															
	2) Gizi															
	3) R. Jatuh															
	4) Obat/riwayat obat minum sebelum MRS/allergi															
	5) Manajemen Nyeri															
	6) PHBS : a. Cuci tangan b. Protkes c. Etika Batuk d. Cega Rokok /KTR/ bebas Utilias rokok															
	7) Fisio tx sesuai kondisi															
	8) Pemakaian alat medis/sesuaikan															
	9) Tiap kali melakukan tindakan															
2	10) Lain-lain															
	11) TTD + nama terang, Tgl, Jam															
	Pemberian informasi di admisi / pendaftaran															
	1) Tata tertib															
	2) Hak & Kewajiban pasien dan keluarga															
	3) Kesediaan															
	4) Fasilitas Kamar															
3	5) Penandaan (Risiko Jatuh, populasi khusus, Risti dll)															
	6) Gelang identitas – identifikasi															
	7) Pemilihan Kamar															
	IRNA															
	1) Nama DPJP + Waktu visite dokter															
	2) Perawat /bidan															
	3) Profesi Pemberi Asuhan lain															
	4) Orientasi Ruangan															
	5) Cara menggunakan toilet, air, listrik, sarpras															



	6) Cara buang sampah																	
	7) Cara memanggil perawat / Nurse call																	
	8) Cara menaruh tempat makanan																	
	9) Cara meminta bimbingan doa																	
	10)Persiapan pasien pulang/ Dischard Planning																	
	11)Biaya																	
	12)Lain-lain																	
	13)TTD + nama terang, tanggal, jam																	
4	Form Edukasi Kolaborasi siapa saja yang visite ?																	
	1) Dokter/DPJP																	
	2) Perawat/Bidan																	
	3) Ahli Gizi																	
	4) Farmasi																	
	5) Rehab medis																	
	6) TTD + nama terang + tgl, Jam																	
	Verifikasi yang dilakukan petugas/ Katim/ Karu																	

Mengetahui,
Kepala Ruang

PIC PKRS Ruang



INVENTARIS ALAT – BARANG PKRS

RUANG :

NO	URAIAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banner												
2	Poster												
3	Papan Majalah Dindin/ Dashboard												
4	Leaflet												
5	Buku Tulis Edukasi Kelompok SAP S/D Umandok												
6	Buku Register PKRS/ Edukasi Individu												
7	Tempat Leaflet/ Map Leaflet/ Tab Edukasi												
8	Stiker Five Moment												
9	Tempat Menyimpanan Dokumen PKRS												
10	Daftar Leaflet dengan Nomor Urut												
11	Map Dokumen : Laporan, Pengukuran Mutu												
12	Map Dokumen – SPO Edukasi												
13	Materi Edukasi, Regulasi di PC unit												
14	Flashdisk Isi Video Edukasi untuk all TV												
15	Petunjuk Ccui Tangan (Stiker)												
16	Alat Peraga Edukasi												
17	Jadwal Edukasi Kelompok minimal 1 bulan												
18	Spidol Permanen												
19	Papanisasi (Petunjuk arah, nama-nama ruangan)												
20	Petunjuk Penggunaan APAR												
21	Stiker / Tanda Risiko Jatuh												
22	Jalur Evakuasi												
23	Lembar Balik												
24	Booklet												

Mengetahui,
Kepala Ruang

PIC PKRS

FORMAT LAPORAN PKRS RSPHS KABUPATEN PASURUAN

INSTALASI/UNIT/RUANG :

NAMA PENGELOLA PKRS UNIT/RUANG/INSTALASI :

LAPORAN BULANAN :



NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YG DIINTERVENSI PKRS		METODE PKRS YG DIGUNAKAN						MEDIA YG DIGUNAKAN							
			FREK (F) X	%	PENYULUHAN INDIVIDU						CETAK		ALAT PERAGA/ MODEL		SIARAN RADIO		AUDIO VISUAL	
					KIE		KONSELING		PRAKTIK									
					F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

Target : KIE : 100% Kasus Target : Penyuluhan Kelompok : 1bln/8x Target Konseling : 75% Kasus

FORMAT LAPORAN PKRS RS PRIMA HUSADA SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

INSTALASI/UNIT/RUANG :
 LAPORAN BULANAN : TAHUN
 NAMA PIC PKRS UNIT/INSTALASI :

MATERI	TANGGAL	PENYULUHAN KELOMPOK								METODE PKRS YANG DIGUNAKAN						MEDIA YANG DIGUNAKAN							
		MG 1		MG 2		MG 3		MG 4		PENYULUHAN KELOMPOK						CETAK		ALAT PERAG A / MODEL		SIARAN RADIO		AUDIO VISAL	
										CTJ		DEMO		ROLE PLAY									
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%

Target : Penyuluhan Kelompok : 1 bln/8x; Minimal dikatakan Kelompok yaitu 5-10 orang ; Materi : sesuai kebutuhan pasien dan keluarga ; bias dilakukan kepada pengunjung/ yang datang menjenguk, komunitas binaan RSPHS ; UMANDOK

CONTOH PEMBUATAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DI UNIT PKRS

Tabel 1. Kebutuhan Diklat & Pelatihan

NO	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN	USUAL ANGGARAN
1	Diklat PKRS Tingkat Terampil (Edukator)	Meningkatnya kompetensi petugas sebagai educator dan Pemberi Informasi edukasi menggunakan media dan metode sesuai asessmen edukasi	- Inhouse Training - Data PPA yang belum ikut diklat - Buat TOR - Rapat, Persiapan, Pelaksanaan - Laporan	PPA	100% para pemberi asuhan 100 org	- Sertifikat peserta - Pelayanan pemberi edukasi 100% kasus	
2	Bimbingan teknis dan TOT bagi tim KE dan PIC-PKRS 2025	Meningkatnya kompetensi Tim KE dan PKRS	- Inhouse Training - Data PPA yang belum ikut diiklat - Buta TOR - Rapat Persiapan – pelaksanaan - laporan	PPA		- Sertifikat peserta - Monev (Check List mutu edukasi)	
3	Diklat manajemen PKRS Standard WHO-Kemenkes	Mengetahui standard terbaru WHO-Kemenkes (Update)	- Diusulkan ke bagian SDM – Diklat, - PT DPM - Daftar ke HPH	Sekretaris Tim PKRS		Seritifikat peserta	
4	Diklat pengembangan media PKRS	Update ilmu pengembangan media PKRS	- Diusulkan ke bagian SDM – Diklat, - PT DPM - Daftar ke HPH	1 orang		Sertifikat peserta	

5	Diklat Instruktur Senam Lansia / Geriatri	Komunitas binaan RSPH F-KUL mempunyai instruktur sendiri	- Diusulkan ke SDM Diklat PHS ke PT DPM, disetujui, daftar - Pelaksanaan, pembuatan laporan	Komunitas Geriatri dan karyawan		Ada instruktur dari RS sendiri tiap kedatangan HR Rp 100.000	Rp. 6.000.000
---	---	--	--	---------------------------------	--	--	---------------

Tabel 2. Fasilitas PKRS (Sarana – Prasarana PKRS sesuai PMK No 44 Tahun 2018)

NO	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN	USUAL ANGGARAN
1	Stabilizer Kamera	Meningkatnya kualitas pelayanan PKRS	Diusulkan	R. PKRS	Januari 2026	Tersedianya 1 Stabilizer untuk kamera	
2	Perawatan Media PKRS	Terpeliharanya Media PKRS	Koordinasi dengan IT dan Gudang untuk pengadaan baterai/sparepart sound	Semua sound yang ada	1 tahun	Tidak ada masalah/ trouble pada sound – radio seluruh ruangan	
3	Rekaman untuk siaran di IG rutin oleh DPJP/Tim PKRS	Meningkatnya kualitas pelayanan PKRS khususnya siaran Radio dan penyimpanan inventaris/media PKRS	Rekaman dokter spesialis tentang penyakit yang sedang ramai	Dokter spesialis Output : hasil rekaman untuk IG sebagai bahan promosi RS	Semua dokter spesialis mengirimkan rekaman video pembahasan penyakit 100%	Hasil rekaman pemberian edukasi & informasi dari dokter spesialis yang ada di PHS	
4	Lemari dan buku untuk program Biblioterapi	Meningkatnya pelayanan Edukasi kepada pasien dan keluarga dengan media biblioterapi	- Diusulkan - Pembuatan TOR - Pembelian	Khususnya di R. VIP	Lemari dan buku motivasi, buku dogeng anak	Program Biblioterapi berjalan baik : 1. Lemari kecil	



						2. Buku-buku yang diperlukan baik anak dan dewasa	
5	Semua referensi masuk di PC unit (pedoman, SPO, alur, Regulasi)	Meningkatnya pelayanan edukasi dengan referensi yang ada di perpustakaan dan unit. Terkait Materi edukasi pasien dan keluarga	Kerjasama dengan Karu, PJ BAB akre, IT, dan PIC PKRS	R. PKRS dan semua unit	Januari 2026	Tersedianya computer dan printer untuk perpustakaan dan arsip materi edukasi	
6	TV tercentral dengan materi edukasi	Meningkatnya pelayanan edukasi melalui video edukasi tercentral	Diusulkan ke bagian pengadaan dan koordinasi dengan IT	R. PKRS	Maret 2026	Tercentralnya saluran TV yang berisi edukasi informasi tentang RSPHS	
7	Pengadaan alat peraga	Terpenuhinya kebutuhan media PKRS di tiap unit		R. PKRS dan poli	Januari 2026	Tersedianya alat peraga sebagai media edukasi di PKRS yang bias dipinjam untuk media edukasi di unit	
8	Lemari untuk lembar balik dan lemari untuk alat peraga	Tersimpannya alat peraga dan lembar balik dengan rapi, baik dan aman	Usulkan melalui SIM Gudang, pengadaan, disetujui PT, FU Kedatangan barang Gudang, distribusi	R. PKRS	Februari 2026	Tersedianya lemari untuk LB dan AP	

Tabel 3. Rencana Pengembangan Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2026

NO	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ JADWAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	USUAL ANGGARAN
1	Pencetakan leaflet materi informasi dan edukasi pada pasien dan keluarga	Tersedianya : materi tertulis untuk edukasi dan informasi	Rapat koordinasi : Menginventaris kebutuhan 1) Perencanaan 2) Pengadaan 3) Pemasangan	1. PKRS unit 2. Manajemen	Leaflet tersedia di tiap unit	Tersedianya : semua materi leaflet sesuai TOR	
2	Pembuatan materi informasi & edukasi melalui papnisasi	Terpenuhinya kebutuhan media PKRS di tiap unit	Rapat : diskusi & menginventarisasi kebutuhan leaflet, poster, alat peraga, media lain	Pigura, papan informasi semua PKRS unit	Rapat	Tersediannya : tulisan-tulisan sebagai informasi pada pelanggan	
3	Pigura akrilik isi poster	Terpenuhinya kebutuhan media PKRS tiap unit	Rapat, usulan, TOR, design, percetakan, pemasangan	Stiker poster tentang 10 penyakit terbanyak	5 macam	Terpasangnya poster stiker berpigura di tiap unit sesuai kebutuhan unit	Minta sponsor
4	Banner	Terpasangnya banner pada peringatan hari-hari besar kesehatan	Usulkan, design, cetak, pasang	1. Hari gizi 2. Hari anak sedunia 3. Hari diabetes 4. HKN 5. Hari Aids sedunia	5 macam / tahun	Terpasangnya banner hari-hari besar tertentu di RSPHS(pagar/masjid)	
5	Pembuatan video untuk edukasi melalui TV/digital signage	Edukasi melalui TV (audio visual)	TOR, pelaksanaan, pelaporan (TUMANDOK)	1. Mata 2. obgyn	2 video edukasi	Tersedianya 2 video baru untuk edukasi melalui TV & digital signage	

6	Pembuatan roll banner	Tersampainya informasi layanan	TOR-design, cetak , pelaporan	Laboratorium dan radiologi	3 buah	Tersedianya info jenis layanan laborat dan radiologi dan kerjasama dengan penjamin	
---	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------	--	--

Tabel 4. Komunikasi Kepada Pasien dan Keluarga

NO	Komunikasi Pasien-Keluarga	TUJUAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN	USUAL ANGGARAN
1	KIE Individu	Meningkatnya peran serta pasien dan keluarga dalam pelayanan yang diterima	Edukasi langsung pada pasien, tuliskan di Form edukasi RM, TTD 2 pihak	Pasien & keluarga	100%	Semua RM terkait bukti edukasi informasi terisi	
2	Konseling / mentoring	Meningkatnya peran serta pasien dan keluarga dalam pelayanan yang diterimanya	Melakukan konseling sesuai kebutuhan	Pasien & keluarga	60%	Ada bukti konseling pasien HIV, TBC dsb	
3	KIE Kelompok	Meningkatnya peran serta pasien dan keluarga dalam pelayanan yang diterimanya	Kumpulkan keluarga di ruangan lalu berikan informasi dan edukasi	Pasien & keluarga	100%	Tiap unit wajib melakukan dan ada laporan	
4	KIE massa (Radio, Video, melalui medsos)	Semua pengunjung tahu pesan-pesan kesehatan melalui radio dan video	Buat rakaman, putar rekaman yang ada	Pengunjung RS	100%	Tersiarikannya KIE ke pasien dan keluarga	

Tabel 5. Pemberdayaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada Sukorejo

NO	Komunikasi Pasien-Keluarga	TUJUAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	USUAL ANGGARAN
1	F-KUL (Forum Kesehatan Usia Lanjut)	Memberdayakan masyarakat dan komunitas + pasien geriatri	Senam lansia tiap jumat, pembinaan konseling melalui WAG	Komunitas muslimat NU ancab Sukorejo	Bukti Tumandok/bln	
2	DOLINA (Duta Online Peduli Ibu dan Anak)	Memberdayakan masyarakat rujukan edukasi	Pertemuan, konseling melalui WAG	Komunitas fatayat ancab sukorejo	Bukti Tumandok/bln	

3	Muslimat-Fatayat, Guru (IGTKI, Himpaudi, RA)	Memberdayakan masyarakat (Corporate Gathering) Rujukan edukasi	Pertemuan Corporate Gathering, konseling melalui WAG, diklat, seminar	Ketua Muslimat-Fatayat ranting, Guru, IGTKI, Himpaudi, RA	Bukti Tumandok/bln	
4	Profesi kesehatan : IDI, IBI, PPNI	Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan organisasi profesi, Pemasaran / meningkatkan jumlah perujuk	Membuat seminar/ zoominar, diklat, workshop	Profesi kesehatan, IDI, IBI, PPNI	Bukti Tumandok	

Tabel 6. Peringatan Hari-Hari Besar : PHBN/PHBA/PHJP/PHBK TAHUN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	BIAYA
1	Hari Gizi Nasional	umum	Edukasi massa	25 Januari	Umandok		
2	Hari Kusta Sedunia	umum	Edukasi massa	27 Januari	Umandok		
3	Hari kanker Sedunia	umum	Edukasi massa	4 Februari	Uamndok		
4	Hari kanker anak sedunia	Umum	Edukasi massa	15 Februari	Umandok		
5	Hari Kesehatan Telinga	umum	Edukasi massa	3 maret	Umandok		
6	Hari Ginjal sedunia	Umum	Edukasi massa	8 Maret	Umandok		
7	Hari Perempuan	Umum	Edukasi massa	8 Maret	Umandok		
8	Hari Air Sedunia	Umum	Edukasi massa	22 Maret	Umandok		
9	Hari TBC Sedunia	Umum	Edukasi massa	24 Maret	Umandok		
10	Hari Kesehatan Dunia	Intern /Ekstr	Edukasi massa	7 April	Umandok		
11	Hari Anak-Balita Sedunia	Intern / Ektrn	Edukasi massa	8 April	Umandok		
12	Hari Kartini	Intern / Ektrn	Edukasi massa	21 April	Umandok		
13	Hari Kanker Tulang	Intern / Ektern	Edukasi massa	11 April	Umandok		
14	Hari Diabet Nasional	Persadia	Senam kaki diabet	18 April	Uamndok	1x	
15	Hari Asma Sedunia	Umum	Edukas massa	1 Mei	Umandok		



16	Hari Palang Merah Sedunia	Umum	Edukasi massa	8 Mei	Umandok		
17	Hari Lupus Sedunia	Umum	Edukasi massa	10 Mei	Umandok		
18	Hari Hypertensi	Umum	Edukasi massa	17 Mei	Umandok		
19	Hari Lanjut Usia	umum	Senam, edukasi	29 Mei	Umandok		
20	Hari Tanpa Tembakau	Umum	Poster	31 Mei	Umandok		
21	Hari Susu Sedunia	Umum	Edukasi massa	1 Juni	Umandok		
22	Hari Bidan Sedunia	Staff	Senam	24 Juni	Umandok		
23	Hari Tanpa Narkoba Sedunia	Umum	Edukasi massa	26 Juni	Umandok		
24	Hari Raya Idul Fitri	Staf, umum	Banner , halal bihalal		Umandok		
25	Hari Keluarga Nasional	Umum	poster	29 Juli	Umandok		
26	Hari Buah Nasional	Umum	poster	1 Juli	Umandok		
27	Hari SBH	-----	-----	17 Juli	Umandok		
28	Hari Anak Nasional	Umum	Edukasi massa	23 Juli	Umandok		
29	Hari Hepatitis Sedunia	Umum	Edukasi massa	28 Juli	Umandok		
30	Pekan ASI	Umum	Workshop, seminar	1-7 Agustus	Umandok	1x	
31	Hari Remaja Asia	Umum	Edukasi massa	1 Agustus	Umandok		
32	Hari Dharma Wanita	DWP	Ikut seminar kab	5 Agustus	umandok	1x	
33	HUT RI	Staf	Lomba-lomba	18 Agustus	Umandok		
34	Hari OR	Staf	Senam	12 September	Umandok		
35	Hari Kesehatan Gigi Nasional	Umum	Edukasi massa	12 September	Umandok		
36	Hari pangan nasional	Umum	Edukasi	16 September	Umandok		
37	Hari PMI	Umum	Edukasi massa	17 September	Umandok		
38	Hari RabieS Sedunia	Umum	Edukasi kelompok	28 September	Umandok		
39	Hari Peduli Hepatitis	Umum	Edukasi Kelompok	15 September	Umandok		
40	Hari Jantung	Umum	Edukasi massa	24 September	Umandok		
41	Hari Hati Sedunia	Umum	Edukasi massa	30 September	Umandok		
42	Hari Penglihatan Sedunia	Umum	Edukasi massa	9 oktober	Umandok		
43	Hari Kesehatan Jiwa	Umum	Edukasi massa	10 Oktober	Umandok		
44	Hari Cuci Tangan	Umum	Edukasi massa	15 oktober	Umandok		

45	Hari Menopause	Umum	Edukasi massa	18 Oktober	Umandok		
46	Hari Osteoporosis	Umum	Edukasi Massa	20 Oktober	Umandok		
47	Hari Dokter Nasional	Umum	poster	24 Oktober	Umandok		
48	Hari Stroke	Umum	Edukasi massa	29 Oktober	Umandok		
49	HKN	Umum	Banner	12 November	Umandok		
50	Hari Diabetes Sedunia	umum	Edukasi massa	14 November	Umandok		
51	Hari Penyakit Paru	Umum	Edukasi massa	15 November	Umandok		
52	Hari HIV-AIDS	umum	Seminar Talk Show	1 Desember	Umandok	1x	
53	Hari Penyandang Cacat Sedunia	Umum	poster	3 Desember	Umandok		
54	Hari IBu	Staf , umum	poster	22 Desember	Umandok		
55	HUT RSPHS	Staf , umum	Seminar, lomba, edukasi massa	11 Januari	Umandok		

Tabel 7. Pengukuran Mutu KIE Pasien dan Keluarga

NO	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	BIAYA
1	Pengukuran mutu kepatuhan pelaksanaan edukasi dan informasi oleh PPA	Mengukur kepatuhan Edukator di tiap ruangan/ unit	1. cek list dokumen 2. telusur pada pasien dan keluarga	Semua unit/instalasi	Dilaksanakannya survey kepatuhan edukator	
2	Presentasi hasil verifikasi /pengukuran mutu kepatuhan PPA	Mengavaluasi kepatuhan PPA	Hasil penelusuran dg cek list ditayangkan di rapat koordinasi	Semua unit/instalasi	Ada perbaikan dari bulan ke bulan	
3	Evaluasi / Laporan Bulanan PKRS	Menilai kinerja PKRS di tiap unit / instalasi	Merekap hasil edukasi baik individua tau kelompok	PKRS unit	Terlaporkannya kegiatan PKRS tiap bulan	
4	Evaluasi pengukuran mutu edukasi tiap unit	Meningkatkan pelayanan edukasi	Umandok	Semua PKRS unit/ instalasi	Tercapainya edukasi sesuai kebutuhan pasien	

JADWAL KEGIATAN PKRS TAHUN

INSTALASI/UNIT/RUANG :

PROGRAM KEGIATAN	SEMESTER	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
KIE INDIVIDU	SEMESTER																								
KIE KELOMPOK																									
PROGRAM KEGIATAN	SEMESTER 2	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
KIE INDIVIDU	SEMESTER 2																								
KIE KELOMPOK																									

Mengetahui,
Kepala Ruang

PIC PKRS Ruang